



ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS

Iolanda Felipe da Silva Bona
Médica de Família e Comunidade
IESC VII



OBJETIVOS

1. Compreender a Coordenação do cuidado à pessoa dependente química.
2. Classificar as substâncias de abuso.
3. Revisar o manejo e a prevenção da dependência de psicoativos (benzodiazepínicos).
4. Interação da APS com CAPS AD.

- O uso de substâncias psicoativas sempre esteve presente nas sociedades humanas, não importando a raça ou a cultura do povo.
- Porém, nas últimas décadas, o aumento significativo de consumidores e dos tipos de drogas usadas tem-se refletido em uma maior demanda para o tratamento dos problemas relacionados com abuso ou dependência de drogas.
- Isso requer um conhecimento básico por parte dos profissionais de saúde sobre a abordagem dos usuários e o seu tratamento, principalmente quanto aos sintomas de intoxicação e abstinência.
- Também é fundamental que esses profissionais saibam o encaminhamento das fases seguintes do tratamento, com o intuito de prevenir a recorrência de problemas relacionados com essas substâncias.



- Desde 2003, definiu-se como responsabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) garantir atenção especializada aos usuários de álcool e outras drogas.
- O atendimento gratuito à população corresponde aos atendimentos prestados nas unidades de atenção primária à saúde (APS), em Centros de Atenção Psicossocial e Centros de Atenção Psicossocial especializados no tratamento de álcool e drogas (CAPS-AD), ambulatórios e outras unidades hospitalares especializadas, internação hospitalar, grupos de autoajuda e comunidades terapêuticas.



CONCEITOS E DIAGNÓSTICOS

- *Droga* é qualquer substância exógena que interfira em um ou mais sistemas do organismo.
- *Droga psicotrópica* ou *substância psicoativa* são as drogas que atuam no funcionamento cerebral, provocando alterações psíquicas e comportamentais.
- *Fissura (craving)* significa um desejo intenso e quase incontrollável de consumir uma substância, muitas vezes com sintomas físicos associados.
- *Uso experimental* corresponde ao uso eventual de uma substância para experimentar seus efeitos, sem recorrência sistemática.
- *Uso ocasional* ou *recreacional* é um uso intermitente em que há algum padrão de consumo, sem causar problemas (físicos, psíquicos, legais, familiares e sociais).



TABELA 114.1 → Critérios do DSM-IV para diagnóstico de uso abusivo de substâncias

- Padrão de uso disfuncional de uma substância levando a um comprometimento ou desconforto clinicamente significativo, manifestado por um ou mais dos seguintes sintomas:
 - Uso recorrente da substância, resultando na falência para preencher obrigações no trabalho, na escola ou em casa.
 - Uso recorrente da substância em situações nas quais poderia haver dano físico.
 - Problemas legais recorrentes relacionados com o uso da substância.
 - Uso contínuo da substância apesar de ter um problema social ou interpessoal persistente ou constante, ou que seria exacerbado pelos efeitos da substância.
-
- Nunca preencher os critérios para dependência para esta substância.
-



TABELA 114.2 → Critérios do DSM-IV para dependência de substâncias

Um padrão de uso disfuncional de uma substância, levando a um comprometimento ou desconforto clinicamente significativo, manifestado por três ou mais dos seguintes sintomas, ocorrendo durante qualquer tempo em um período de 12 meses:

- Tolerância, definida por um dos seguintes critérios:
 - Necessidade de quantidades nitidamente aumentadas da substância para atingir intoxicação ou o efeito desejado.
 - Efeito nitidamente diminuído com o uso contínuo da mesma quantidade de substância.
 - Abstinência, manifestada por um dos seguintes critérios:
 - Síndrome de abstinência característica da substância.
 - A mesma substância (ou outra bastante parecida) é usada para aliviar ou evitar sintomas de abstinência.
 - A substância é frequentemente usada em grandes quantidades ou por período maior do que o intencionado.
 - Um desejo persistente ou esforço sem sucesso de diminuir ou controlar a ingestão da substância.
 - Grandes períodos de tempo utilizados em atividades necessárias para obter a substância, usá-la ou recuperar-se dos seus efeitos.
 - Redução ou abandono das atividades sociais, recreacionais ou ocupacionais por causa do uso da substância.
 - Uso continuado da substância, apesar do conhecimento de ter um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que tenha sido causado ou exacerbado pela substância.
-

HISTÓRIA NATURAL E FATORES DE RISCO PARA USO DE DROGAS

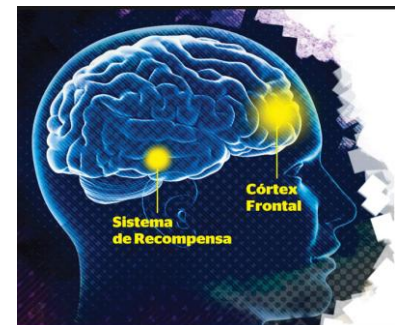
- Nos estágios iniciais, os indivíduos que irão desenvolver um transtorno pelo uso de substâncias são geralmente indistinguíveis de seus pares.
- Um risco maior de dependência em adolescentes está associado a:
 - ❑ Episódios frequentes de intoxicação;
 - ❑ Uso de drogas com maior potencial de dependência (cocaína, opioides);
 - ❑ Preferência pelas rotas de administração com início de efeito mais rápido (injetável ou na forma de *crack*).



TABELA 114.4 → Fatores de risco e proteção para o uso de drogas

DIMENSÃO	FATORES DE RISCO	FATORES DE PROTEÇÃO
Culturais e sociais	→ Permissividade social → Disponibilidade de droga → Extrema privação econômica → Morar em favela	→ Ambiente estável → Alto grau de motivação → Forte vínculo com os pais
Interpessoais Na infância	→ Família com problema de conduta relacionado com álcool ou drogas → Manejo familiar pobre e inconsistente Na adolescência → Conflitos familiares e abuso físico ou sexual → Eventos estressantes (como mudança de casa e escola) → Rejeição dos seus pares na escola ou em outros contextos → Associação com amigos usuários	→ Supervisão parental e disciplina consistentes → Ligação com instituições pró-social → Associação com amigos com conduta mais convencional
Psicocomportamentais	→ Problema de conduta precoce e persistente → Fracasso escolar → Vínculo frágil com a escola → Personalidade anti-social → Outras psicopatologias (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, depressão e transtorno de conduta, ou ansiedade nas mulheres) → Inabilidade de esperar gratificação	
Biogenéticos	→ Genealogia positiva para dependência química → Vulnerabilidade psicofisiológica ao efeito de drogas	

- O entendimento sobre os mecanismos que levam à dependência ainda está no começo, e sua origem é provavelmente multifatorial.
- Acredita-se que a dependência química ocorra pela estimulação do sistema de recompensa cerebral.
 - ❑ O sistema de recompensa tem participação fundamental na busca de estímulos causadores de prazer.
 - ❑ Por meio do reforço positivo da recompensa, obtida durante a experimentação de uma substância psicoativa, o organismo é impelido a buscá-la repetidas vezes, pois se cria uma memória específica para isso, sendo a dopamina o principal neurotransmissor responsável por esse mecanismo.



QUANDO SUSPEITAR DO USO DE DROGAS

- Piora do desempenho na escola e no trabalho.
- Falta de motivação para as atividades comuns.
- Pouca tolerância em relação a frustrações e autoridade.
- Mudanças bruscas do comportamento ou no humor.
- Conflitos com a lei, por violação de regras de trânsito, vandalismo e furtos.
- Queixas físicas semelhantes às de uma “ressaca”: vômitos e indisposição de estômago pela manhã, dor de cabeça, boca seca, fadiga e sede.
- Isolamento da vida familiar, de amigos, de atividades sociais, ou então vida social exageradamente intensa.



- Marcas de injeções.
- Amnésia recente, não lembrando o que fez no dia anterior.
- Uso excessivo de produtos que refrescam o hálito e colírio (para disfarçar os efeitos da maconha).
- Uso de óculos escuros, mesmo sem excesso de luz, e de camisas de mangas compridas, mesmo no calor.
- Desaparecimento de objetos de valor ou presença de comprimidos estranhos.
- Voz pastosa, hálito alcoólico, falta de coordenação motora, apatia, olhos avermelhados, pupilas dilatadas, agitação.
- Queimaduras nos lábios, língua e rosto (*crack*) e hiperemia perioral (inalantes).
- Sinais inespecíficos como pressão arterial elevada, arritmia cardíaca.



- É essencial orientar os pais de adolescentes sobre os indícios de que seus filhos possam estar consumindo drogas.
- O caminho mais seguro para os pais é informar-se o máximo possível sobre as drogas, seja lendo artigos, participando de palestras ou debatendo questões com quem conhece do assunto.
- Mais do que apenas detectar, a família terá munição para enfrentar o problema da melhor forma possível.



ABORDAGEM INICIAL DA PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

- É importante estabelecer, desde o início do atendimento, um vínculo adequado com os pacientes usuários de substâncias.
- Muitas vezes, eles chegam desconfiados, desmotivados ou mesmo obrigados por seus familiares.
- Com frequência também, a queixa que os traz é outra, e eles não estão preparados para abordar a questão da dependência química.
- Perguntas mais abertas e não confrontativas ou preconceituosas reduzem a ansiedade do paciente, a negação e resistência ao tratamento.
- A entrevista de familiares neste momento pode ajudar a confirmar a veracidade das informações fornecidas pelo paciente e introduzir a família no plano terapêutico.

ANAMNESE

- Deve abordar as substâncias utilizadas e seu padrão de uso, os tratamentos anteriores, as comorbidades clínicas e psiquiátricas, a história familiar de doença psiquiátrica e uso de drogas, o perfil psicossocial e o exame do estado mental.
- Padrão de uso:
 - Data de início do uso; dificuldade de controle após a primeira dose; doses e frequência do consumo; locais e companhia para o consumo; velocidade ou tempo de consumo para cada dose; efeitos e suas durações; principais situações que precipitam o consumo; horários de consumo; data do último consumo.



- É importante investigar as modalidades de tratamento anteriores, se o tratamento foi individual ou em grupo, hospitalar ou ambulatorial, quais as medicações utilizadas e a resposta obtida com cada tipo de tratamento.
 - ❑ Outro aspecto relevante a ser observado é o comprometimento com os tratamentos anteriores, isto é, se foram voluntários ou impostos por familiares ou pela justiça.
- O uso de drogas pode ser causa, consequência ou ocorrer em paralelo a sintomas psiquiátricos.
 - ❑ Indivíduos com comorbidade psiquiátrica e abuso de substâncias têm um prognóstico pior do que pacientes com apenas um desses transtornos e são de difícil tratamento.
- É essencial, também, saber sobre o uso de álcool e drogas na família, especialmente para o planejamento terapêutico, pois o envolvimento familiar no tratamento é de suma importância.

EXAME FÍSICO



- Sempre deve ser realizado um exame neurológico, uma vez que o impacto das substâncias psicoativas no SNC é significativo.
- Não existem sinais patognomônicos do uso de substâncias psicoativas, mas alguns sintomas podem levantar suspeita do uso de drogas:
 - ❑ Sonolência ou agitação;
 - ❑ Alterações da marcha;
 - ❑ Aceleração ou lentificação da fala e do pensamento;
 - ❑ Alterações da frequência cardíaca e da pressão arterial
 - ❑ Irritação nasal e das conjuntivas;
 - ❑ Odor de maconha, inalantes ou outra substância psicoativa;
 - ❑ Cicatriz indicativa de punção venosa nos membros superiores, queimaduras nos dedos das mãos (*crack*).



EXAMES COMPLEMENTARES



- Os exames laboratoriais devem levar em consideração o tipo de droga utilizado e os sintomas apresentados pelos pacientes.
- Abuso de álcool: TGO, TGP, Gama GT, hemograma.
- Drogas injetáveis ou associadas a comportamento sexual de risco: anti-HIV, anti-HCV, anti-HBs, HbsAg e VDRL.
- Os exames toxicológicos de urina, quando disponíveis, são muito úteis se houver dúvida quanto ao relato do paciente e devem ser utilizados em um contexto de colaboração entre paciente, avaliador e familiares.
 - ❑ Estão disponíveis os exames de maconha, benzodiazepínicos, cocaína, solventes, anfetaminas e álcool.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA INICIAL

- Após a avaliação inicial, é necessário definir um plano de tratamento junto com o paciente, que pode ser feito por meio de intervenção breve por profissional de APS, encaminhamento para um grupo terapêutico ou de autoajuda, avaliação ou tratamento com psiquiatra e psicólogo e internação hospitalar ou em comunidades terapêuticas.
- Além disso, muitas vezes é preciso recorrer à terapia de família e ao auxílio de um assistente social.
- Alguns casos podem ser encaminhados ao especialista em saúde mental já no início do acompanhamento:
 - ❑ Pacientes com suspeita de comorbidade psiquiátrica, aqueles que não melhoraram com os recursos disponíveis e os que já tiveram múltiplas tentativas de abstinência sem sucesso.

- A internação hospitalar pode ser necessária quando o paciente apresentar:
 - ❑ Condições médicas ou psiquiátricas que exijam observação constante (estados psicóticos graves, ideação suicida ou homicida, debilitação ou abstinência grave) e complicações orgânicas devidas ao uso ou à cessação do uso da droga;
 - ❑ Dificuldade para cessar o uso de drogas, apesar dos esforços terapêuticos;
 - ❑ Ausência de adequado apoio psicossocial que possa facilitar o início da abstinência;
 - ❑ Necessidade de interromper uma situação externa que reforce o uso da droga.
- As comunidades terapêuticas e as fazendas para tratamento de dependentes químicos possuem as mais variadas orientações teóricas e, em geral, utilizam uma filosofia terapêutica baseada em disciplina, trabalho e religião.

CAPS AD

- O acesso ao CAPS AD ocorre para homens e mulheres maiores de 18 anos que tem problemas com o uso de álcool e outras drogas que chegam a unidade por demanda espontânea ou encaminhados por outros serviços de apoio do município de Teresina – Piauí.
- A atenção ao usuário é realizada por uma equipe multiprofissional – psiquiatra, clínico geral, psicólogo, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, artesão, redutor de danos e técnico de enfermagem.

CAPS AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, n° 2978 - Bairro Macaúba-Teresina/PI CEP 64016-060.

Fone: 3215-7762

E- mail: capsadthe@gmail.com

Horário de Funcionamento: segunda a sexta – feira nos turnos manhã e tarde

- Dependendo da gravidade do problema, realiza tratamento intensivo, no qual o paciente é atendido de segunda a sexta-feira, o dia todo; o semi-intensivo, em que a frequência é de pelo menos três dias da semana; e o não-intensivo, que se resume a um dia da semana.

1. Acolhimento;
2. Busca ativa;
3. Tratamento individualizado e em grupo;
4. Matriciamento com as equipes das UBS;
5. Visita domiciliar;
6. Administração de mediação;
7. Assembleias com usuário e comunidade.

DROGAS DE USO FREQUENTE

- Uma classificação útil para as substâncias psicoativas é feita de acordo com os efeitos mais proeminentes no SNC:
 - ❑ As drogas depressoras tendem a diminuir a atividade motora e a reatividade à dor e à ansiedade, sendo também comum um efeito euforizante inicial e posterior sonolência.
 - ❑ As estimulantes produzem um aumento do estado de alerta, insônia e aceleração dos processos psíquicos.
 - ❑ As perturbadoras geram diversos fenômenos psíquicos anormais, como alterações sensoperceptivas (alucinações e ilusões) e delírios.

TABELA 114.5 → Classificação das substâncias psicoativas

DEPRESSORES DO SNC

- Álcool
- Benzodiazepínicos
- Barbitúricos
- Opiáceos
 - Naturais: morfina, codeína
 - Sintéticos: meperidina, propoxifeno, metadona
 - Semissintéticos: heroína

ESTIMULANTES DO SNC

- Cocaína
- Nicotina
- Anfetaminas e drogas de ação semelhante (anfetamínicos)
- Cafeína
- MDMA (*ecstasy*)

PERTURBADORES DO SNC

- Derivados da *Cannabis*: maconha, haxixe, THC
- Derivados indólicos: plantas e cogumelos
- Sintéticos: LSD-25, MDMA (*ecstasy*)
- Anticolinérgicos
- Outras substâncias em doses adequadas

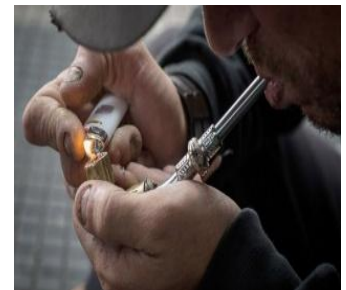
COCAÍNA



- Pode ser inalada, ingerida, absorvida pelas mucosas ou injetada após diluição em água.
- O uso agudo produz euforia, sensação de aumento de energia e da autoestima, diminuição da fadiga e da necessidade de sono, aumento do desejo sexual, aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial.
- À medida que o consumo torna-se crônico, os efeitos prazerosos diminuem e surgem ansiedade, disforia, sonolência, sintomas depressivos e paranoides, além de aumentar a fissura pela substância e disfunções sexuais, incluindo impotência, incapacidade de ejaculação e diminuição do desejo sexual.
- O uso injetável pode ocasionar infecções cutâneas no local da aplicação, endocardite bacteriana e infecções transmitidas pelo compartilhamento de seringas, agulhas e outros acessórios, como HIV e hepatites B e C.

CRACK

- Os efeitos agudos e crônicos do uso de *crack* são semelhantes aos da cocaína, visto que é um derivado desta.
- Vem sendo cada vez mais associado a criminalidade, agressividade e mortalidade precoce dos usuários.
- O perfil do usuário de crack é de uma população predominantemente masculina, jovem, solteira, de baixa classe socioeconômica, baixo nível de escolaridade e sem vínculos empregatícios formais.
- Ainda não existe medicação considerada eficaz para o tratamento da dependência de *crack*.



MACONHA

- Devido à dificuldade de quantificar seus níveis séricos, não há doses formais definidas que produzem a dependência, e seu risco acaba sendo proporcional à extensão do consumo.
 - ❑ A maioria dos usuários não se torna dependente.
- Provoca euforia e relaxamento, alterações da sensopercepção, distorção do tempo e intensificação de experiências sensoriais comuns.
- Os efeitos desagradáveis mais comuns, principalmente em usuários ocasionais, são ansiedade e reações de pânico.



BENZODIAZEPÍNICOS



- Estão entre as drogas mais frequentemente prescritas no mundo, devido às suas propriedades sedativas, ansiolíticas, hipnóticas, amnésicas, antiepilépticas e de relaxamento muscular.
- Estima-se que 50 milhões de pessoas façam uso diário de BZD, sendo a maior parte delas formadas por mulheres acima de 50 anos que apresentam doenças crônicas.
- As intoxicações são caracterizadas por vários níveis de sedação e depressão do SNC, diminuindo as funções cardíacas e respiratórias.
 - ❑ No tratamento, além do suporte clínico adequado, da manutenção dos sinais vitais e de avaliações cardiorrespiratória e neurológica, utiliza-se flumazenil 1 mg IV em 1 a 3 minutos ou 1 a 5 mg IV em 2 a 10 minutos.

- Sintomas de retirada podem surgir mesmo nas doses geralmente prescritas pelos médicos, após utilização diária superior a duas a três semanas.
 - ❑ Incluem cefaleia e ansiedade, insônia, tremor e fadiga, bem como sintomas de rebote, alterações da percepção, tinido, sudorese e diminuição da habilidade de concentração.
 - ❑ A retirada ou diminuição abrupta de doses altas de BZD pode precipitar delirium, algumas vezes com sintomas psicóticos e convulsões.
- A dependência de BZD pode ser prevenida pela adesão às recomendações para o curto prazo de prescrição (até 2 a 4 semanas, quando possível) e também por baixas doses.
 - ❑ Quando as doses são maiores e o uso é crônico, recomenda-se que a retirada seja gradual.

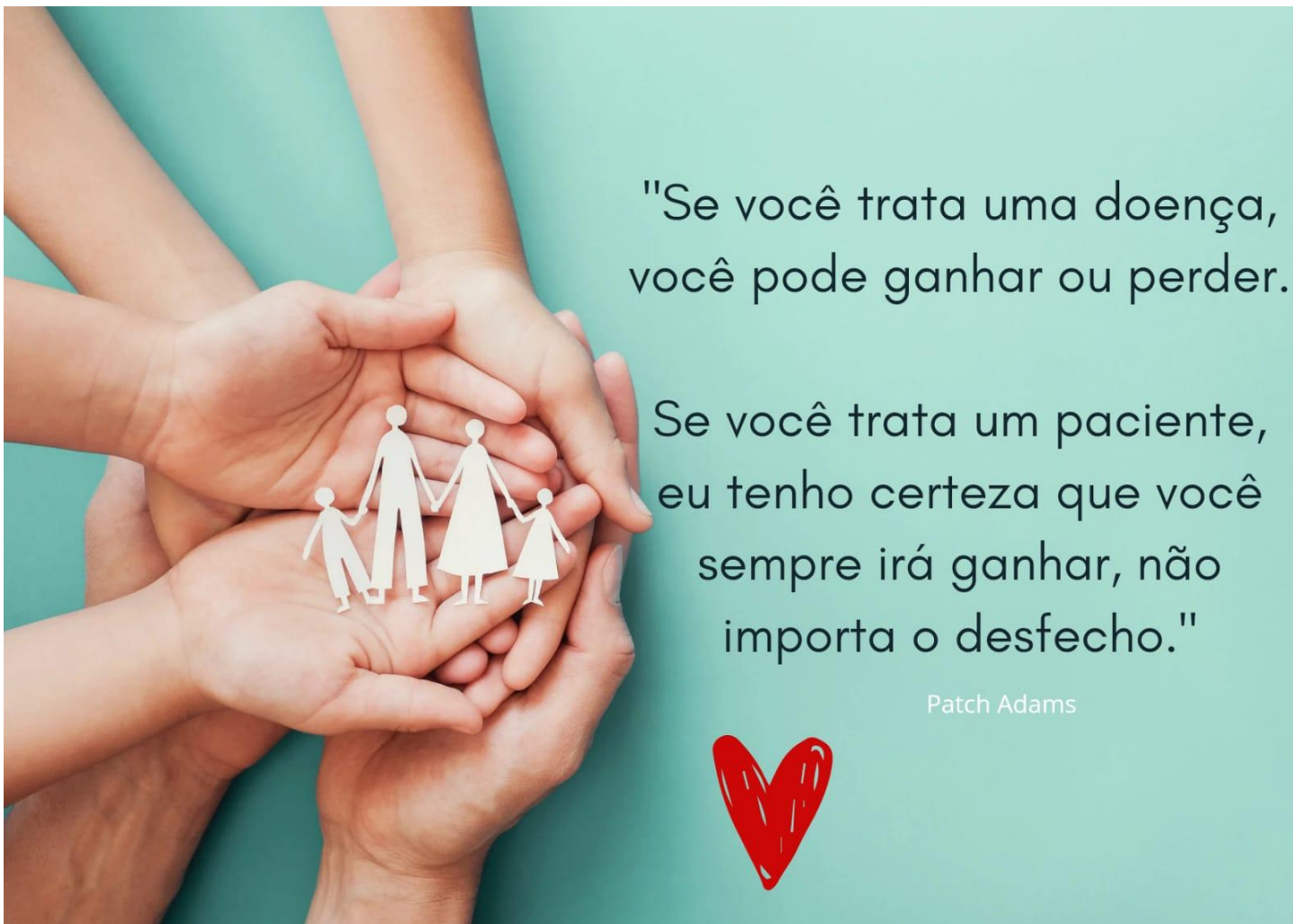
PROGNÓSTICO

- Apesar de haver certa heterogeneidade, a maioria dos indivíduos com dependência de substância psicoativa apresenta um curso crônico.
- Períodos de uso sustentado são intercalados por outros de remissão parcial ou completa.
- A abstinência é mais frequentemente mantida por aqueles que se vinculam a algum tratamento formal ou grupo de autoajuda.
- A maioria dos pacientes tratados para dependência de drogas (mais de 70% em alguns estudos) é capaz de parar com o uso compulsivo ou abster-se da droga em algum momento da vida.
- Um número menor (15 a 20%) tem um padrão crônico de recaídas ao longo de 10 a 20 anos.

Referências Bibliográficas

DUNCAN, B, B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em evidências. Disponível em: Minha Biblioteca, (5th edição). Grupo A, 2022. (Cap. 114).

A Política do Ministério da Saúde para atenção integral a usuários de álcool e outras drogas. Ministério da Saúde.



"Se você trata uma doença,
você pode ganhar ou perder.

Se você trata um paciente,
eu tenho certeza que você
sempre irá ganhar, não
importa o desfecho."

Patch Adams



Obrigada!